MEDSINA 2027

MIND MAP : SYNDROMES CORONARIENS AIGUS (SCA ST+ / ST-)

Module de Cardiologie • Préparation Officielle Concours de Résidanat

GOOGLE DRIVE CLOUD

1 Définition & Physiopathologie

- Mécanisme principal : Rupture ou érosion d'une plaque d'athérome vulnérable avec formation d'un
- SCA ST+ (IDM transmural) : Thrombus totalement occlusif → Nécrose myocardique transmurale
- SCA non ST+ (SCA ST-) : Thrombus sub-occlusif ou embolisation distale micro-vasculaire → Ischémie
- Si troponine positive = NSTEMI (Infarctus sans sus-décalage de ST).

2 Démarche Diagnostique Immédiate

- Clinique : Douleur thoracique constrictive, rétrosternale, irradiant vers la mâchoire et le
- ECG 12 dérivations + dérivations postérieures (V7-V8-V9) et droites (V3R-V4R) à réaliser et
- Critères SCA ST+ : Sus-décalage ST convexe vers le haut ≥ 1 mm dans au moins 2 dérivations
- Image en miroir très évocatrice.

3 Stratégie de Reperfusion du SCA ST+ (ESC

- Objectif absolu : Reperfusion la plus précoce possible (« Le temps, c'est du muscle »).
- Si délai Premier Contact Médical (PCM) → Gonflement de ballonnet ≤ 120 minutes :
- Angioplastie Primaire (Coronarographie) est la méthode de référence absolue.
- Si délai > 120 minutes (zone éloignée, transport long) :

4 Traitement Antithrombotique d'Urgence

- Double Antiagrégation Plaquettaire (DAPT) :
- Aspirine : 150 à 300 mg IV ou PO à croquer, puis 75 mg/j à vie.
- Inhibiteur P2Y12 puissant : Ticagrélor (180 mg charge puis 90 mg x2/j) ou Prasugrel (60 mg charge
- Anticoagulation parentérale : Enoxaparine (0,5 mg/kg IV bolus) ou HNF (bolus 70-100 UI/kg).

CŒUR DU SUJET CLINIQUE

Syndromes Coronariens Aigus (SCA ST+ / ST-)

Algorithme & Notions Haute Tombabilité

5 Traitement Médical au Long Cours : Ordon

- B : Bêtabloquant (Bisoprolol ou Métoprolol titré)
- A : Antiagrégant plaquettaire (Aspirine à vie + P2Y12 pendant 12 mois)
- S : Statine à forte dose (Atorvastatine 80 mg ou Rosuvastatine 20 mg, cible LDL < 0,55 g/L)
- I : IEC (Ramipril ou Périndopril titré préventif du remodelage ventriculaire)

6 Pièges Concours & Vigilance Annales

- Piège Annales : Attendre la troponine devant un tableau clinique typique avec sus-décalage ST à
- Piège Dérivés Nitrés : Contre-indication formelle des dérivés nitrés si PAS < 90 mmHg ou si
- Piège Traitement : L'association Prasugrel est contre-indiquée en cas d'antécédent d'AVC/AIT ou

7 Points Clés Incontournables

- ECG 12 dérivations + V7-V8-V9 et V3R-V4R interprété en moins de 10 minutes.
- Angioplastie primaire de référence si délai PCM-ballon ≤ 120 min ; Fibrinolyse immédiate si
- Ne JAMAIS attendre les résultats de la troponine pour déclencher la reperfusion d'un SCA ST+.
- DAPT systématique : Aspirine + Ticagrélor ou Prasugrel pendant 12 mois minimum.

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES : Douleur angineuse > 20 min + Sus-décalage persistant du segment ST (≥ 1 mm dans 2 dérivations contiguës ou BBG récent)

TRAITEMENT CLÉ : Reperfusion urgente (Angioplastie < 120 min ou Fibrinolyse Ténectéplase) + DAPT (Aspirine + Ticagrélor) + Anticoagulatio